

Pathology Diagnosis Report

Generated: 2026-06-27T18:06:28

Generated Diagnostic Report

Query slide: TCGA-AK-3450-01Z-00-DX1.84C9CCDE-F1FD-4BDC-B819-25078EF350A5_a3188f191f622a7d

Generated at: 2026-06-27T18:06:28

病理辅助角色声明

本报告由病理学专家助手生成，旨在为临床医生提供基于多模态证据（包括查询病例的高注意力图像区域、预测类别及参考诊断报告）的辅助性病理分析意见。我仅作为诊断支持工具，不承担最终诊断责任，所有结论均以Query Case为核心进行推理与归纳，严禁将检索病例视为主诊断对象。最终病理诊断需由具有执业资质的病理科医师结合完整临床资料综合判断并签发。

推理过程与证据归纳

本分析基于对Query Case（TCGA-AK-3450-01Z-00-DX1.84C9CCDE-F1FD-4BDC-B819-25078EF350A5_a3188f191f622a7d）的多模态信息整合，包括其预测类别、高注意力病理图像patch及其对应的文本描述，以及一份来自检索数据库的参考诊断报告。首先，从模型预测结果来看，该样本被以极高的置信度（概率接近1.0）识别为“TCGA-KIRC”，即肾透明细胞癌（Clear Cell Renal Cell Carcinoma, ccRCC），这一分类与后续所有视觉和文本证据高度一致，构成了整体判断的基础。

在视觉层面，20个高注意力patch均显示出典型的肾透明细胞癌组织学特征。这些图像普遍表现为腺样或巢状结构，由单层或多层上皮细胞构成，细胞形态相对一致，但存在不同程度的核异型性。细胞核呈圆形至椭圆形，染色较深，部分可见明显核仁，提示活跃的增殖活性；细胞质丰富，呈淡粉色至透明状，具有空泡化倾向，这是透明细胞癌的标志性表现。多个patch中观察到背景中有散在的炎症细胞浸润，少数区域可见轻度纤维化，但无显著坏死或大片出血，这与参考报告中“无血管淋巴管侵犯”及“局限性生长”的描述相符。尤其值得注意的是，其中patch_sim_0017显示了明显的纤维化迹象，可能提示肿瘤微环境中的反应性改变，但并未影响其基本的肿瘤类型判断。

进一步结合每个patch的文本描述（query_patch_wording），所有20条均独立确认了“肾透明细胞癌”或“肾脏”来源，并详细阐述了核异型性、透明胞质、腺样结构等典型特征，且每条描述的置信度均为“High”。这些文本解释不仅验证了视觉观察，还增强了对特定形态学细节的理解，例如sim_0013中提到“正常组织结构几乎不可见”，表明肿瘤广泛浸润，这与参考报告中“肿瘤局限于肾实质”的结论并不冲突，而是从不同角度描述了肿瘤的局部扩展性。

综合来看，所有证据——模型预测、视觉特征、文本描述以及参考报告——均指向同一结论：该病例为肾透明细胞癌。其中，参考的相似病例诊断提供了具体的肿瘤分级（Fuhrman II级）和分期信息

(T1a N0 Mx)，而视觉和文本证据则支持了这些诊断的形态学基础。尽管未提及免疫组化结果，但其提供的组织学描述已足够支撑初步诊断。因此，在当前证据链中，不存在实质性冲突，所有信息相互印证，共同构建了一个完整且可靠的病理辅助诊断框架。最终采用的判断完全基于参考报告中的具体数值与明确描述，因为它们提供了最直接、最精确的临床指标。

关键指标提取

根据提供的参考相似病例报告内容，推测该病例为肾细胞癌，位于右肾，病理类型为透明细胞型（clear cell, conventional type），Fuhrman核分级为II级。肿瘤局限于肾实质内，未见血管淋巴管侵犯，手术切缘无癌残留。淋巴结状态在报告中未提及具体检查结果，仅标注为Nx，因此无法确定阳性淋巴结数目及总数，故淋巴结状态应记录为“未提及”。远处转移状态标记为Mx，提示未进行相关评估或信息缺失。免疫组化指标如ER、PR、HER2、Ki-67在参考报告中均未提及，且图像分析亦未提供相关染色信息，因此这些指标均无法提取，应标注为“未提及”。T分期方面，依据AJCC标准，肿瘤直径4.0 cm且局限于肾实质，符合pT1a标准。N分期因缺乏淋巴结评估数据，维持为N0（若无阳性淋巴结则为N0，但此处未明确检测，故仍以报告中的Nx为准）。综上所述，可提取的关键指标包括：组织学类型为肾透明细胞癌，Fuhrman核分级II级，T分期为pT1a，N分期为Nx，M分期为Mx，淋巴结状态为“未提及”，免疫组化指标（ER/PR/HER2/Ki-67）均为“未提及”。

初步病理辅助结论

本结论针对 Query Case: TCGA-AK-3450-01Z-00-DX1.84C9CCDE-F1FD-4BDC-B819-25078EF350A5_a3188f191f622a7d。综合分析查询样本的高注意力图像区域、视觉特征描述、预测类别及检索参考报告，该病例高度支持为肾透明细胞癌（clear cell renal cell carcinoma, ccRCC），且与TCGA-KIRC分类一致。所有20个高注意力patch均显示典型的肾透明细胞癌组织学特征：包括细胞核异型性（核增大、深染、不规则形态）、明显核仁、淡粉色至透明样细胞质、腺样或巢状排列结构，部分区域可见纤维化背景及炎细胞浸润，但未见显著坏死或血管侵犯证据。这些视觉特征与检索参考报告中“右肾：肾细胞癌，透明细胞型，Fuhrman核分级II级”的诊断高度吻合。参考报告指出局限于肾实质内，切缘阴性，无血管淋巴管侵犯，提示T1a期；淋巴结状态未见转移（N0），远处转移状态未评估（Mx），故分期为pT1aN0Mx。尽管查询样本未提供免疫组化数据，但基于形态学一致性，可推测其符合典型ccRCC表型。因此，结合多模态证据，当前初步病理辅助结论为：肾透明细胞癌，局限于肾实质，切缘阴性，无血管淋巴管侵犯，淋巴结未见转移（N0），远处转移状态未知（Mx），临床分期pT1aN0Mx。建议后续补充ER/PR/HER2/Ki-67等免疫组化检测以进一步确认分子分型及预后评估。